

 SST Azienda USL Toscana sud est Servizio Sanitario della Toscana <u>Direzione P.O. Aretino, Casentino, Valtiberina e Valdichiana Aretina</u>	PP-PARE-70 Procedura per la gestione del paziente con diagnosi di tumore gastrointestinale sospetto o accertato	Rev. n. 0 Pag. 1 di 7
---	---	-------------------------------------

<i>Fasi</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Data</i>
Redazione	Per il gdl	Chiara Salini	 CHIARA SALINI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.07.2023 09:18:50 UTC	
Verifica	Coordinatore GOM Tumori Colon.Retto Area Aretina	Marco Rossi	 MARCO ROSSI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.07.2023 10:38:47 UTC	
	Direttore Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche	Vianella Agostinelli	 VIANELLA AGOSTINELLI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.07.2023 07:58:23 GMT+0200	
	Direttore Dipartimento Chirurgia Generale	Andrea Coratti	 ANDREA CORATTI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.07.2023 07:07:23 UTC	
Approvazione	Direttore Presidio Ospedaliero dell'Aretino, Casentino, Valtiberina e Valdichiana Aretina	Barbara Innocenti	 BARBARA INNOCENTI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.07.2023 07:27:18 UTC	
Controllo	UOS Qualità e Sicurezza delle cure Area provinciale Senese	Laura Brunelli	 LAURA BRUNELLI REGIONE TOSCANA/01386030488 05.07.2023 10:53:40 UTC	

Gruppo di lavoro composto da: Marco De Prizio, Duccio Venezia, Carlo Milandri, Andrea Carnevali, Duccio Venezia, Simona Borghesi, Gianni Mura, Michele Sisani, Marta Angelini, Pasquale Petruzzi, Elena Cavargini, Sabrina Del Buono, Paola Belardi, Anna Carbonai.

Luogo e modalità di conservazione: Segreteria Ospedale di Arezzo	Responsabile Antonella Bianchi
---	-----------------------------------

La diffusione del presente documento è assicurata mediante pubblicazione nell'intranet aziendale. Essa inoltre verrà distribuita, a cura della struttura emittente, alla seguente lista di strutture organizzative:

1. UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza degli stabilimenti – SO Arezzo, Cortona, Bibbiena, Sansepolcro
2. UOC Oncologia - SO Arezzo
3. UOS Ambulatorio e Day Hospital Oncologico - SO Cortona, Bibbiena, Sansepolcro
4. UOC Radiologia - SO Arezzo
5. UOS Radiologia - SO Cortona, Bibbiena, Sansepolcro
6. UOSD Radiologia Vascolare ed Interventistica - SO Arezzo
7. UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - SO Arezzo
8. UOC Radioterapia - SO Arezzo
9. UOC Anatomia Patologica - SO Arezzo
10. Direzione Infermieristica – SO Arezzo, Cortona, Bibbiena, Sansepolcro

INDICE

PREMESSA.....	3
SCOPO.....	3
CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
GLOSSARIO E ACRONIMI.....	4
MODALITÀ OPERATIVE.....	4
1) Paziente non ricoverato.....	5
2) Paziente ricoverato.....	5
3) Pazienti provenienti da aree provinciali afferenti al Presidio di Arezzo.....	6
MONITORAGGIO.....	6
RESPONSABILITÀ (matrice delle responsabilità).....	6

PREMESSA

L'aumento negli ultimi decenni della diagnosi di tumore e parallelamente il miglioramento della prognosi dovuto alla scoperta di nuove terapie mediche e chirurgiche ha modificato l'approccio del paziente oncologico richiedendo non più la presa in carico da parte di un singolo specialista, ma un approccio multidisciplinare del caso clinico mediante il coinvolgimento di più specialisti.

L'approccio globale e multi-specialistico, nelle varie fasi del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, pone al centro il paziente coinvolgendolo attivamente nel percorso e ponendo sempre più attenzione alle sue necessità ed alle sue scelte. La multidisciplinarietà, inoltre, contrasta le frammentarietà del processo di cura e assicura una tempestiva e coordinata organizzazione delle attività con una attenzione centrale al raggiungimento di una buona qualità di vita in relazione alla patologia oncologica e, assicurando un percorso ben definito, riduce il disorientamento e l'ansia del paziente.

Il Presidio degli Ospedali Riuniti dell'Aretino (ORA), di cui l'Ospedale S. Donato rappresenta lo stabilimento di riferimento, è costituito da 4 Stabilimenti Ospedalieri (Ospedale San Donato di Arezzo, Ospedale di Bibbiena, Ospedale di Sansepolcro e Ospedale Santa Margherita della Fratta).

Attualmente la diagnosi di tumore gastrointestinale può arrivare a seguito di esame eseguito in Ospedale, in regime di ricovero (Day Hospital o ordinario) o ambulatoriale, oppure a seguito di esame eseguito presso struttura privata accreditata. In caso di necessità di intervento chirurgico, questo viene effettuato presso l'Ospedale S. Donato con la possibile collaborazione dei Professionisti provenienti dagli altri ospedali del Presidio. Gli esami diagnostici necessari alla stadiazione e la presa in carico del paziente sono centralizzati sia per sfruttare al meglio le tecnologie avanzate presenti nel Presidio provinciale sia per uniformare le procedure fin dalla presa in carico. Alla dimissione dal S. Donato, il paziente viene affidato ai servizi di oncologia delle zone di provenienza per le eventuali cure e per i controlli.

Si rende pertanto necessario definire un percorso per la presa in carico multidisciplinare di tutti i pazienti con diagnosi di neoplasia sospetta o accertata del tratto gastrointestinale, indipendentemente dalla residenza del paziente e dalla sede in cui è stato posto il sospetto diagnostico, al fine di migliorare la compliance e la qualità di trattamento del paziente stesso.

SCOPO

Questa procedura si pone l'obiettivo di definire dei criteri condivisi e standardizzati di gestione per contrastare la frammentazione dei percorsi, promuovere l'importanza della multidisciplinarietà nella cura del paziente e definire un percorso univoco per la presa in carico e il successivo trattamento del paziente con tumore gastrointestinale sospetto o accertato.

Lo scopo finale è garantire un percorso omogeneo e personalizzato per tutti i pazienti, promuovendo al tempo stesso attività di aggiornamento e ricerca per migliorare la prognosi.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente procedura si applica all'Ospedale San Donato, all'Ospedale di Bibbiena, di Sansepolcro e all'Ospedale della Fratta di Cortona, a tutte le UU.OO. di Chirurgia Generale, Oncologia, Radiologia, Radiologia Interventistica, Anatomia Patologia, Radioterapia, Gastroenterologia degli Ospedali di Arezzo, Casentino, Valtiberina e Valdichiana aretina.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Delibera Regione Toscana n° 32 del 14/01/2019 “Gruppi Oncologici Multidisciplinari per le neoplasie dell'età adulta”
- Decreto Regione Toscana n° 699 del 23/01/2019 “Rete Oncologica Regionale - Approvazione modello di referto GOM”
- Deliberazione del DG n° 1191 del 29/10/2019 “Nomina Coordinatori dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) per le neoplasie dell'età adulta nell'ambito della rete oncologica”
- PD-DONC-004 “Protocollo per la presa in carico del paziente oncologico”

GLOSSARIO E ACRONIMI

- GOM: Gruppo Oncologico Multidisciplinare
- DMPO: Direzione Medica di Presidio
- PDTA: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
- GIST: Tumori Stromali Gastrointestinali
- ISPRO: Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

MODALITÀ OPERATIVE

I gruppi oncologici multidisciplinari (GOM) sono costituiti da un insieme di specialisti di discipline diverse che partecipano alla definizione e all'attuazione pratica del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) dei pazienti oncologici.

Presso l'Ospedale S. Donato sono organizzati tre tipi di incontri multidisciplinari destinati alla discussione e presa in carico dei pazienti con diagnosi di neoplasia:

- ***L'ambulatorio oncologico di presa in carico***, costituito da medico chirurgo, oncologo e infermiere di percorso, che si riunisce il giovedì mattina nell'Ospedale S. Donato;
- ***L'ambulatorio oncologico multidisciplinare deliberato GOM***, costituito da: Chirurgo Generale, Oncologo, Radioterapista, Radiologo, Gastroenterologo, Patologo, Infermiere di percorso, che si riunisce il giovedì pomeriggio nell'Ospedale S. Donato;

- **Ambulatorio oncologico multidisciplinare aziendale**, che coinvolge specialisti facenti parte degli ospedali dell'Azienda Sud Est e che si riunisce in modalità da remoto a lunedì alternati per discutere dei casi a maggiore complessità.

Di seguito verranno descritti i percorsi per la presa in carico multidisciplinare dei pazienti a seconda del tipo di provenienza della diagnosi.

1) Paziente non ricoverato

In caso di esame ambulatoriale effettuato in Ospedale o in struttura privata accreditata da cui derivi una sicura o altamente probabile diagnosi di neoplasia dell'apparato gastroenterico, il paziente viene indirizzato all'ambulatorio di presa in carico previa comunicazione effettuata dal gestore del caso attraverso la mail gom.sandonato@uslsudest.toscana.it.

Presso l'ambulatorio di presa in carico, gli specialisti incontrano il paziente e concordano un appuntamento per eseguire in regime di Day Service Oncologico la stadiazione della patologia. Si precisa che al fine di accelerare il più possibile il percorso di diagnosi e cura, sono attribuiti all'ambulatorio multidisciplinare GOM delle disponibilità di slot in Day Service dedicate e preferenziali.

All'ambulatorio di presa in carico è presente anche un infermiere dedicato case manager (infermiere di percorso) che ha la funzione di controllare, verificare e ottimizzare il percorso di presa in carico e di stadiazione: esso segue tutto l'iter diagnostico terapeutico verificando percorsi, criticità, tempi di attesa, medici di riferimento, rapporti con il paziente.

Completata la stadiazione i medici dell'ambulatorio di presa in carico decidono se concludere a tale livello il percorso avviando il paziente alla terapia indicata (chemioterapia o chirurgia) oppure se inviare il caso clinico all'ambulatorio GOM multidisciplinare. Le patologie oncologiche che devono essere inviate all'ambulatorio multidisciplinare sono: tumore esofago-gastrico, tumore retto, tumore pancreatico-biliare, tumori primitivi epatici, tumori rari (GIST, neuroendocrini, ecc). In caso di tumore metastatico, il paziente viene inviato in qualsiasi caso all'ambulatorio GOM multidisciplinare.

Durante il GOM multidisciplinare viene redatta una relazione su documento ISPRO, come da Decreto n. 699 del 23.01.2019. I medici GOM al termine della discussione dei casi, incontrano il paziente per comunicare la decisione di percorso concordata. Il paziente viene affidato al Medico tutor di competenza per la scelta terapeutica fatta e inizia il percorso di trattamento, che potrebbe anche prevedere ulteriori esami e accertamenti. La presenza dell'infermiere di percorso case manager è prevista anche durante l'ambulatorio oncologico multidisciplinare, per assicurare la continuità della presa in cura infermieristica.

Se il paziente viene avviato ad una terapia neoadiuvante, appena questa sarà conclusa, il caso sarà nuovamente ridiscusso in sede GOM multidisciplinare.

Il GOM multidisciplinare potrà avvalersi della discussione in sede di GOM aziendale nei casi di maggiore complessità.

Se previsto dal percorso terapeutico deciso per il paziente e se richiesto da quest'ultimo, i trattamenti antitumorali sistemici possono essere eseguiti presso le oncologie di riferimento territoriale. Mentre, si precisa, i trattamenti chirurgici dovranno essere eseguiti presso l'Ospedale San Donato.

2) Paziente ricoverato

Per il paziente ricoverato, il reparto di degenza chiede consulenza oncologica. L'oncologo avvia, ove necessario, il percorso di stadiazione. Per ottimizzare la presa in carico del paziente, gli accertamenti richiesti per la stadiazione vengono eseguiti, per quanto possibile, durante la degenza, se il motivo del ricovero è legato a sintomatologia correlata con la patologia oncologica. Appena completata la stadiazione, il reparto di degenza segnala il paziente all'ambulatorio multidisciplinare di competenza (oncologico di presa in carico o GOM multidisciplinare) per corretta valutazione e creazione di percorso personalizzato.

Se il paziente è ricoverato per altri motivi e la diagnosi oncologica è un riscontro occasionale che non richiede la permanenza in ricovero, le indagini di stadiazione vengono organizzate dopo la dimissione con modalità analoga al percorso per esterni.

Nel caso in cui il paziente sia ricoverato presso uno stabilimento ospedaliero in cui una o più indagini di stadiazione non possono essere eseguite, l'oncologo, di concerto con il medico che ha in carico il paziente ricoverato, valuta l'opportunità di centralizzare il paziente oppure organizzare accertamenti successivamente al ricovero da effettuarsi a stretto giro.

I Medici degli stabilimenti periferici (chirurghi, oncologi, e altre branche se coinvolte nel caso) che effettuano la diagnosi di neoplasia partecipano in presenza o in collegamento da remoto alle sedute multidisciplinari di presa in carico e/o GOM multidisciplinare.

3) Pazienti provenienti da strutture convenzionate

In caso di esame diagnostico effettuato presso struttura convenzionata esterna da cui derivi una sicura o altamente probabile diagnosi di neoplasia dell'apparato gastroenterico, il paziente viene indirizzato all'ambulatorio di presa in carico previa comunicazione effettuata dal gestore del caso attraverso la mail gom.sandonato@uslsudest.toscana.it.

Durante la discussione del caso clinico all'ambulatorio di presa in carico è prevista, oltre alle figure sopra elencate, la presenza del Medico inviante appartenente alla struttura convenzionata, il quale prenderà parte alla discussione del caso e alla relativa scelta diagnostico terapeutica. Alla fine della visita, il Paziente potrà scegliere in quale struttura vorrà proseguire il percorso di cura (pubblica o privata convenzionata).

MONITORAGGIO

- **Casi discussi all'ambulatorio di presa in carico** su n° tot di **referti istologici risultati positivi o sospetti** per neoplasia del tratto gastrointestinale => 100%
- **Casi discussi all'ambulatorio deliberato GOM** sul n° tot di **neoplasie invasive** del tratto gastrointestinale => 100%
- **Casi discussi all'ambulatorio di presa in carico** su n° tot di **neoplasie del tratto gastrointestinale diagnosticate nella provincia di Arezzo** => 100%

RESPONSABILITÀ (matrice delle responsabilità)

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ				
Professionisti /Attività	DMPO	Medico che effettua diagnosi di neoplasia GI	Infermiere di percorso Case Manager	Medico tutor
1 Applicazione della procedura	R	C	C	C
2 Segnalazione tumore GI sospetto o accertato	I	R	C	C
3 Controllare, verificare e ottimizzare il percorso di presa in carico	I	I	R	C
4 Prendere in carico e seguire il paziente durante il percorso di trattamento	I	I	C	R